Reseau de Sante Vitalite
Health Network
Centre Hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont
Dr. Georges-L-Dumont University Hospital Centre
Moncton, N.-B.
CONSULTATION. # D266700- EXT
Nom/Name: PALK-RICARD, JOEL
ASS. -Mal./Med.: 919461343
D.N./D.O.B.: 23 10 1989
Tel.: (506)389-8708
cc:Michel-Alexandre LeBreton, M.D., FRCSC (Orthopedic Surgeon)
Translated for Elivia Morrison, M.D.
Chris Losier, M.D.CopyText
IMPORTANT NOTICEThis document is an English translation of the report dictated in French. The English version is provided solely for information purposes. Only the original French language version is official.
Date: October 1, 2013

Dear Colleagues,

We have assessed Joel. He is a young right-handed 23-year-old man. He goes to college. He is known for asthma. He is not taking any medications. He is allergic to Clavulin and Bactrim. He does not smoke.

This man was playing football yesterday. He suffered a direct impact to the left forearm after direct contact with another player. He felt a sharp pain at the level of the ulnar aspect of the forearm. There is no obvious deformity or wound.

He was initially seen at The Moncton Hospital and was diagnosed with a fracture at the level of the middle third of the ulnar bone. A sling was installed. I saw the patient today. He is in fasting state. The sling is removed and there is no wound. There is a sharp pain at the level of the middle and proximal third of the ulnar bone. There is no pain at the level of his wrist or shoulder. The neurovascular status is intact. The compartments are supple.

The X-rays are showing a nightstick fracture, which is slightly displaced and for which surgery is indicated considering the fact that these fractures rarely heal by themselves. We explained the risks and complications, including infection, neurological involvement, bleeding, periprosthetic fracture, painful material and non-union. He understands very well and accepts the risks.

We will schedule surgery.

Michel-Alexandre LeBreton, M.D., FRCSC (Orthopedic Surgeon)

Dict: 01 10 2013 Transcr.: 16 10 2013
MAL/jh Job: 896815/213187009/12/2013 10:39:56
/md Job: 909652/0
Translator/Date: Manon Desrosiers (06 12 2013)

COPIE ORIGINALE SIGNEE AU DOSSIER

Hopital Docteur Georges Dumont PCI LIVE (PCI: OE Database HDD)

Reseau de Sante Vitalite
Health Network
Centre Hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont
Dr. Georges-L-Dumont University Hospital Centre
Moncton, N.-B.
CONSULTATION. # D266700- EXT
Nom/Name: PALK-RICARD, JOEL
ASS. -Mal./Med.: 919461343
D.N./D.O.B.: 23 10 1989
Tel.: (506)389-8708
cc:Michel-Alexandre LeBreton, M.D., FRCSC (Orthopediste)
Elivia Morrison, M.D.
Chris Losier, M.D.

Date: le 1er octobre 2013

Chers collegues,

Nous avons evalue Joel. C'est un jeune homme de 23 ans qui est droitier. Il est au college. Il est connu pour des antecedents d'asthme. Il ne prend aucun medicament. Il possede une allergie au Clavulin et Bactrim, et il est non fumeur.

C'est un homme qui jouait au football hier. Il a eu un impact direct au niveau de l'avant-bras gauche suite a un contact avec un autre joueur, une douleur vive au niveau du versant cubital de l'avant-bras a ete constatee. Aucune difformite evidente, aucune plaie.

Il fut donc vu initialement a l'Hopital Moncton City pour lequel une fracture du cubitus tiers moyen a ete diagnostiquee. Il a donc ete pose en attelle. J'ai donc revu le patient ce jour, et il est a jeun. L'attelle est alors retiree, aucune plaie. Il y a une douleur vive au niveau du cubitus tiers moyen et tiers proximal. Aucune douleur au niveau du poignet ni au niveau du coude, ni au niveau de l'epaule. L'examen neurovasculaire est intact. Les loges sont souples.

Au niveau des rayon-x souples, on constate une fracture de type night stick qui est legerement deplacee pour laquelle une indication chirurgicale est de mise considerant le fait que ces fractures guerissent par eux-memes que tres rarement. Nous avons donc explique les risques et les complications qui comprennent infection, atteinte neurologique, saignement, fracture periprothetique, materiel douloureux, non union. Il comprend tres bien et accepte les risques.

Nous allons donc le ceduler pour cette chirurgie.

Michel-Alexandre LeBreton, M.D., FRCSC (Orthopediste)

Dict: 01-oct.-2013 Transcr.: 16-oct.-2013
Date de diffusion/Date available: 25/11/2013 15:05:34
MAL/jh Job: 896815/2131870

COPIE ORIGINALE SIGNEE AU DOSSIER
ORIGINAL SIGNED IN THE CHART

Reseau de Sante Vitalite
Health Network
Centre Hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont
Dr. Georges-L-Dumont University Hospital Centre
Moncton, N.-B.
PROTOCOLE OPERATOIRE
OPERATIVE REPORT.# D266700- ADMUR
Nom/Name: PALK-RICARD, JOEL
ASS. -Mal./Med.: 919461343
D.N./D.O.B.: 23 10 1989
Tel.: (506)389-8708
cc:Michel-Alexandre LeBreton, M.D., FRCSC (Orthopediste)
Date: Le 1er octobre 2013
Diag. Pre-op. dx: Fracture du cubitus, tiers moyen/tiers proximal gauche.
Diag. Post-op. dx: Fracture du cubitus, tiers moyen/tiers proximal gauche.
PROTOCOL (E): Sous anesthesie generale et intubation endotracheale, reduction ouverte et fixation interne du cubitus gauche avec plaque et vis Smith & Nephew.

ANESTHESISTE : Dr LaPlante.

Le patient fut entre en salle d'operation le 1er octobre 2013. 2 g d'Ancef fut donne par voie intraveineuse a l'appel. Apres anesthesie generale et intubation endotracheale, le patient est place en decubitus dorsal sur table maquet avec table a main. Garrot augmente a la racine du membre superieur gauche. Celui-ci est monte a une pression de 250 mmHg pour un total de 30 minutes durant la chirurgie. Badigeon au SoluPrep et drapage fait de facon standard.

Debutons par une incision centree sur la crete du cubitus sur une longueur d'environ 10 cm. Le plan est alors approfondi avec le ciseau Steven. Nous avons donc identifie le site de la fracture, deperioste le site fracturaire et curete les berges de la fracture. Nous avons donc choisi une plaque " small frag " de six trous Smith & Nephew " locking ". Nous avons donc fixe la plaque initialement avec vis corticales avec un effet de compression et par la suite aux extremites, nous avons fixe avec des vis auto-verrouillantes.

Le tout est alors verifie sous fluoroscopie en AP et en lateral et est juge adequat. La pronation/supination est alors faite et on constate que la plaque est donc tres stable. Nous avons donc lave de facon abondante le site chirurgical et referme le plan perioste avec du Vicryl 0 en points en X et le plan sous-cutane a l'aide de Vicryl 0 en points inverses. Des agrafes sont posees a la peau. Les pertes sanguines furent evaluees a 50 cc. Aucune complication durant le protocole operatoire. Le decompte des compresses et des equipements est fait a deux reprises et est complet. Le patient retourna a la salle de reveil de facon stable avec un etat neuro-vasculaire intact et une attelle posterieure a l'avant-bras gauche.

Michel-Alexandre LeBreton, M.D., FRCSC (Orthopediste)

Dict: 01-oct.-2013 Transcr.: 01-oct.-2013
Date de diffusion/Date available: 27/11/2013 13:01:46
MAL/nrd Job: 893365/2132207

COPIE ORIGINALE SIGNEE AU DOSSIER
ORIGINAL SIGNED IN THE CHART